

PROTOCOLE DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Aide à la prise des traitements « Si besoin »

Référence : Circuit du médicament – Chapitre 2 | Application : Ensemble des professionnels concernés de l'établissement
Date de création : 19 juin 2026 | Date de mise à jour : 03 juillet 2026

1 OBJECTIF

Sécuriser l'aide à la prise des traitements prescrits « si besoin », en définissant clairement les modalités de collaboration entre l'équipe éducative, l'équipe infirmière, l'encadrement et le médecin, afin de garantir la sécurité du résident, la traçabilité des actes et la réévaluation des situations.

2 CHAMP D'APPLICATION

Ce protocole s'applique aux résidents disposant d'une prescription médicale nominative, datée et signée, précisant les conditions d'utilisation d'un traitement « si besoin ».



Toute situation d'urgence vitale ou de gravité immédiate impose un appel sans délai au SAMU – Centre 15.

3 CONDITIONS INDISPENSABLES

- Prescription médicale explicite : indication clinique, posologie, délai minimal entre deux prises, dose maximale / 24 h, modalités de surveillance.
- Traitement clairement identifié et accessible selon l'organisation interne de l'établissement.
- Aucune aide à la prise ne peut être réalisée en dehors du cadre prévu par la prescription et par le présent protocole.
- Toute intervention doit faire l'objet d'une traçabilité dans le dossier de soins.
- La prescription médicale précise explicitement si l'administration du traitement « si besoin » nécessite l'intervention d'un auxiliaire médical (IDE), compte tenu de la nature du produit et de la nécessité d'apprécier l'état clinique du résident (art. L.313-26 du Code de l'action sociale et des familles).
- En l'absence de cette précision, l'appréciation de la situation par un IDE ou un médecin reste requise avant toute administration.

4 PROCÉDURE DE COLLABORATION

1 Repérage par l'équipe éducative

- Sécurise le résident.
- Observe les signes cliniques, le contexte et l'heure de survenue.
- Alerte immédiatement l'IDE.
- Ne décide pas seule de l'administration d'un traitement.

2 Analyse et décision par l'IDE

- Évalue la situation clinique du résident.
- Vérifie la prescription : indication, délai depuis la dernière prise, dose maximale non atteinte.
- Confirme ou non la conduite à tenir.
- Précise les modalités de surveillance et de réévaluation.
- Cette validation est requise avant chaque administration, sans exception liée à l'horaire ou à l'organisation du service.

3 En l'absence d'IDE sur site

- Applique les premières mesures non médicamenteuses adaptées à la situation.
- Contacte systématiquement, avant toute aide à la prise, l'IDE d'astreinte ou, à défaut, le médecin, pour obtenir une appréciation de l'état du résident et une validation explicite.
- Appelle immédiatement le 15 en cas d'urgence, d'aggravation, de doute sérieux ou de signes de gravité.
- Si aucun professionnel de santé n'est joignable : ne pas administrer. Sécuriser le résident, appliquer les mesures non médicamenteuses, solliciter le 15 en cas de doute.
- Toute aide à la prise reste subordonnée à une prescription valable et à une validation clinique préalable obtenue au moment de la situation.

4 Traçabilité et transmissions

- Date et heure.
- Motif clinique observé.
- Nom du médicament et dose.
- Professionnel ayant réalisé l'aide à la prise.
- IDE ou médecin contacté / heure.
- Nom, fonction et heure du professionnel ayant validé l'administration avant l'aide à la prise.
- Effets observés et transmission à l'équipe suivante.

Etablissement

Médecin

PROTOCOLE DE COLLABORATION INTERPROFESSIONNELLE

Aide à la prise des traitements « Si besoin »

Référence : Circuit du médicament – Chapitre 2 | Application : Ensemble des professionnels concernés de l'établissement
Date de création : 19 juin 2026 | Date de mise à jour : 03 juillet 2026

5 RÔLE DES PROFESSIONNELS

Encadrant éducatif (ES/AES/AMP)	repère, sécurise, alerte, aide à la prise après validation explicite de l'IDE ou du médecin, surveille et trace.
IDE	évalue, vérifie la prescription, décide de la conduite à tenir, organise la surveillance, assure la traçabilité et la formation des équipes.
Cadre de santé / cadre d'astreinte	veille à l'application du protocole, apporte un appui organisationnel, contrôle la bonne circulation des informations.
Médecin prescripteur	rédige une prescription claire, précise les conditions d'utilisation du « si besoin », réévalue la pertinence du traitement.
SAMU – Centre 15	régule les situations urgentes lorsque nécessaire.

6 SURVEILLANCE ET RÉÉVALUATION

Toute utilisation d'un traitement « si besoin » nécessite une surveillance adaptée de l'efficacité et de la tolérance.
En cas de recours fréquent ou répété, la situation doit être signalée en réunion clinique afin de réévaluer le traitement de fond avec le médecin.

RÈGLE INCONTOURNABLE

Aucune aide à la prise d'un traitement « si besoin » sans validation préalable d'un IDE ou d'un médecin, obtenue au moment de la situation.
En cas d'impossibilité de joindre un professionnel de santé : ne pas administrer - sécuriser le résident, appliquer les mesures non médicamenteuses, solliciter le 15 en cas de doute.



APPEL IMMÉDIAT AU 15 SI :

Détresse respiratoire, perte de connaissance, crise convulsive prolongée ou répétée, suspicion de fausse-route sévère, hémorragie importante, altération brutale de l'état général, ou toute situation jugée inquiétante.

Mention de sécurité

Document cadre à adapter aux procédures internes de l'établissement et au livret du circuit du médicament.
Version de travail – Juillet 2026 | Références juridiques : art. L.313-26 du Code de l'action sociale et des familles ; TA Dijon, 25 janvier 2026 ; CAA Lyon (confirmation en appel)

Fait à :

Le : / /

Signature :